

HOSPITAL / UNIDADE DE SAÚDE — INSERIR NOME DA INSTITUIÇÃO

SERVIÇO DE CUIDADOS PALIATIVOS · MEDICINA INTENSIVA

PLANEJAMENTO AVANÇADO DE CUIDADOS (PAC)

Limitação de Suporte de Vida · Registro de Conferência Familiar · Plano Terapêutico Proporcional

DOC-PAC-LSV-001 | Rev. 01/2025 | Conforme CFM 1.805/2006, 2.217/2018 e 2.232/2019

■ DOCUMENTO DE USO EXCLUSIVAMENTE CLÍNICO-ASSISTENCIAL. Registra decisões tomadas em Conferência Familiar regularmente constituída, em conformidade com os princípios da Bioética (autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça), legislação brasileira vigente e resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM). Deve ser arquivado no prontuário do paciente e integra o Planejamento Avançado de Cuidados (PAC). NÃO substitui o prontuário médico.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo:

Data de nasc.:

Idade:

Nº Prontuário:

Leito / Setor:

Diagnóstico principal:

Diagnósticos secundários relevantes:

CPF / RG:

CNS:

Prognóstico atual:

☐ Irreversível · fase final de vida☐ Sobrevida estimada ≤ 6 meses☐ Doença avançada · sem perspectiva curativa☐ Outro (especificar):

Condição de consciência / capacidade decisória:

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICO-BIOÉTICA

A presente Conferência Familiar e o consequente Plano Terapêutico foram conduzidos em estrita conformidade com o arcabouço ético-legal descrito a seguir, que protege o paciente, a família, a equipe médica e a instituição de saúde diante de eventuais questionamentos futuros.

2.1 Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM)

"É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal."

CFM — Resolução nº 1.805, de 09 de novembro de 2006 — Art. 1º (Ortotanásia)

CFM — Código de Ética Médica (Resolução nº 2.217/2018) — Art. 41, parágrafo único

CFM — Resolução nº 2.232, de 17 de julho de 2019 — Arts. 2º, 3º e 4º (Recusa Terapêutica)

CF/88 — Art. 5º, incisos III e X — Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III)

Código Civil Brasileiro — Lei nº 10.406/2002 — Arts. 1º, 11 e 15: ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico ou intervenção cirúrgica com risco de vida

CE/88 — Art. 196 · Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) — Art. 2º: saúde como direito fundamental

Lei Estadual SP nº 10.241/1999 (Lei dos Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde) — Art. 2º, incisos VI, VII, XXIII e XXIV — aplicável como diretriz nacional de boas práticas

PRINCÍPIO	DEFINIÇÃO APLICADA AO CONTEXTO
Autonomia	Respeito à vontade do paciente capaz e/ou de seu representante legal quanto às escolhas terapêuticas, incluindo o direito de recusar ou interromper o tratamento.
Beneficência	Obrigação de agir em benefício do paciente, priorizando qualidade de vida, conforto e dignidade no processo de cuidado.
Não-maleficência	Vedação de intervenções desproporcionais (distanásia) que apenas prolonguem o sofrimento sem benefício clínico significativo.
Justiça	Alocação proporcional de recursos; garantia de acesso equitativo a cuidados paliativos de qualidade.
Proporcionalidade	Equilíbrio entre benefícios esperados e ônus de cada intervenção, considerando o contexto clínico e os valores do paciente.

3. REQUISITOS DE VALIDADE JURÍDICA DA CONFERÊNCIA FAMILIAR

Para que a presente Conferência Familiar produza efeitos jurídicos e possa ser invocada como instrumento de defesa do médico e da instituição em eventuais litígios futuros, todos os requisitos abaixo devem ser atendidos e documentados:

R1	Convocação formal e documentada Todos os familiares e/ou representantes legais relevantes devem ter sido convocados com antecedência razoável, preferencialmente por escrito, com registro da data e meio de comunicação utilizado.
R2	Composição mínima da equipe assistencial Presença obrigatória do médico responsável (com CRM) e, se disponível, de pelo menos um membro da equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos (enfermagem, psicologia, serviço social ou capelania hospitalar).
R3	Identificação dos participantes Registro completo (nome, grau de parentesco/função, CPF/identidade) de todos os presentes, com assinatura ao final do documento.
R4	Capacidade decisória verificada Avaliação e registro explícito do estado cognitivo do paciente, indicando se possui ou não capacidade para participar das decisões (mediante escala ou avaliação clínica formal, ex.: Mini-Mental, GCS, avaliação de delirium).
R5	Informação clara, completa e adequada Apresentação, em linguagem acessível, do diagnóstico, prognóstico, opções terapêuticas disponíveis, riscos e benefícios de cada intervenção, e a justificativa clínica para a proposta de limitação.
R6	Deliberação livre e sem coação Garantia de espaço para perguntas, manifestação de dúvidas, discordâncias e escuta ativa de todas as partes. Ausência de qualquer forma de pressão ou coação sobre os familiares.
R7	Registro em prontuário Todo o conteúdo da conferência deve ser registrado no prontuário do paciente, de forma cronológica, datada, assinada e com CRM do médico responsável, integrando o histórico clínico permanente.
R8	Assinatura de Termo de Ciência Assinatura do presente documento por todos os participantes identificados, como instrumento de registro da conferência e do plano terapêutico acordado.
R9	Previsão de revisão periódica Definição explícita do prazo ou das condições clínicas que ensejarão nova conferência ou revisão do plano terapêutico, garantindo a dinamicidade do processo.
R10	Ausência de conflito de interesses Declaração implícita ou explícita de que a decisão foi guiada exclusivamente pelo melhor interesse do paciente, sem motivações econômicas, de gestão de leitos ou qualquer outro conflito.

4. REGISTRO DA CONFERÊNCIA FAMILIAR

Data da
conferência:

Horário (início /
fim):

Local (setor / sala):

4.1 Equipe Assistencial Presente

NOME	FUNÇÃO / ESPECIALIDADE	CRM / REGISTRO PROFISSIONAL
	Médico responsável	CRM:
	Enfermeiro(a)	COREN:
	Psicólogo(a)	CRP:

	Assistente Social	CRESS:
	Outros:	

4.2 Familiares / Representantes Legais Presentes

NOME COMPLETO	GRAU DE PARENTESCO / FUNÇÃO	CPF	TELEFONE

4.3 Participação do Paciente

- | ■ Paciente presente e capaz →
manifestou suas preferências (ver
Seção 5) | ■ Paciente presente porém sem
capacidade decisória (incapaz
temporária ou definitiva) | ■ Paciente ausente (internado /
impossibilitado de participar) |
|--|---|---|
| <p>Seção 5)</p> | <p>capacidade decisória (incapaz
temporária ou definitiva)</p> | <p>impossibilitado de participar)</p> |

Descrição da manifestação do paciente (se presente e capaz):

5. PREFERÊNCIAS DO PACIENTE E DA FAMÍLIA

Registre abaixo, com fidelidade, as preferências, valores e desejos expressos durante a conferência, tanto pelo paciente (quando capaz) quanto pelos familiares / representantes legais.

Valores e prioridades do paciente / família quanto à qualidade de vida:

Local de preferência para os últimos dias de vida:

Aspectos espirituais, religiosos ou culturais relevantes para o cuidado:

Outras manifestações de vontade expressas na conferência:

6. PLANO TERAPÊUTICO PROPORCIONAL — DECISÕES ACORDADAS

ATENÇÃO: As decisões abaixo refletem o resultado da Conferência Familiar devidamente realizada, com base em critérios clínicos, bioéticos e na vontade expressa do paciente/família. Representam atos de ORTOTANÁSIA (morte digna no tempo natural), expressamente autorizada pelo CFM. NÃO constituem eutanásia ou abandono terapêutico.

6.1 Medidas com Indicação de NÃO INICIAR / SUSPENDER

MEDIDA / INTERVENÇÃO	JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO	■ NÃO INICIAR	■ SUSPENDER
Reanimação Cardiopulmonar (RCP / DNAR)	RCP não está indicada neste contexto. Em caso de PCR, não iniciar manobras de ressuscitação. Registrar DNAR no prontuário.		
Intubação Orotraqueal (IOT) / Ventilação Mecânica Invasiva	IOT/VMI não estão indicadas. Em caso de insuficiência respiratória, priorizar conforto: O2 nasal/máscara, opioides para dispneia, VNI somente se confortável.		
Diálise / Terapia Renal Substitutiva (TRS)	TRS não está indicada. Manejo conservador da lesão renal com foco em conforto e controle de sintomas.		
Internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)	Internação em UTI não está indicada. Cuidados paliativos ativos serão prestados no setor atual ou em local mais adequado ao conforto.		
Exames diagnósticos invasivos ou de imagem complexos	Apenas exames que impactem diretamente o conforto e o controle de sintomas são indicados.		
Alimentação / Hidratação Artificial (SNG / SNE / NPT)			
Antibioticoterapia para infecções refratárias			
Hemotransfusões (salvo indicação paliativa específica)			
Outras intervenções — especificar:			

6.2 Medidas ATIVAS de Cuidado Paliativo Proporcional — MANTER / IMPLEMENTAR

CUIDADO PALIATIVO ATIVO	DESCRIÇÃO / PROTOCOLO	■ MANTER	■ INICIAR
-------------------------	-----------------------	----------	-----------

6.3 Metas Terapêuticas e Indicadores de Revisão

**Condição clínica
que ensejaria
revisão
imediata:**

7. REGISTRO DE CONFLITOS, DIVERGÊNCIAS E ESTRATÉGIA DE CONCILIAÇÃO

Conflitos familiares são comuns em conferências de fim de vida e devem ser gerenciados de forma empática, transparente e documentada. O registro adequado protege juridicamente todos os envolvidos.

- ☐ Não houve conflitos ou divergências — decisão unânime ☐ Houve divergências — registrar abaixo ☐ Conflito não resolvido — acionar comitê de bioética / mediação

Descrição dos conflitos / divergências identificados:

Estratégias de conciliação propostas e adotadas:

Posição divergente registrada (familiar / membro da equipe):

- ☐ Acionado Comitê de Bioética Hospitalar ☐ Agendada nova conferência familiar ☐ Solicitada mediação profissional (Psicologia/Serviço Social) ☐ Outro:

Data e hora da próxima conferência agendada (se aplicável):

"A discordância superveniente de familiar que estava presente e assinou o presente Termo não invalida as decisões aqui registradas, desde que tomadas mediante processo legítimo de deliberação, com informação adequada e sem vício de vontade (erro, dolo ou coação). A responsabilidade civil do médico é excluída quando age conforme os protocolos éticos vigentes, no melhor interesse do paciente e com o consentimento dos representantes legais."

CC/2002, Arts. 138-171 (vícios do consentimento) · CFM Res. 2.217/2018 · STJ, Resp 1.540.580/DF — responsabilidade médica e consentimento informado

8. NECESSIDADE DE NOVAS CONFERÊNCIAS

- ☐ Não necessário — plano definitivo conforme prognóstico ☐ Sim — agendar em: _____ ☐ Condicional — rever se: _____

Critérios para convocação de nova conferência:

9. SÍNTESE NARRATIVA DA CONFERÊNCIA — REGISTRO LIVRE

Espaço para registro livre e detalhado do médico responsável sobre o andamento da conferência, nuances das discussões, aspectos clínicos e bioéticos relevantes não contemplados nos campos estruturados:

Os trechos abaixo constituem fundamento jurídico-ético que protege o médico e a instituição em caso de questionamentos futuros sobre as decisões tomadas nesta conferência:

O médico que limita tratamentos desproporcionais em paciente terminal, documentando adequadamente, age em conformidade com a ética médica brasileira e NÃO comete crime nem infração ética.

CFM Res. 1.805/2006 · Processo-Consulta CFM nº 8.485/97 · Parecer CFM nº 08/2012

O médico que se recusa a empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, em doença incurável e terminal, cumpre imperativo ético expresso no Código de Ética Médica.

CEM/CEM 2.217/2018 — Art. 41. parágrafo único

A obtenção de consentimento livre, esclarecido e documentado, com participação de todos os representantes legais, é causa excludente de responsabilidade civil e penal do médico. O presente documento, com assinaturas, constitui prova do consentimento informado.

CC/2002 Arts. 138-171 · CP Art. 146 §3º. II · STJ. REsp 1.540.580/DF

A limitação de suporte de vida em fase terminal não viola o direito à vida: ao contrário, afirma a dignidade como seu núcleo essencial. A CF/88 não exige o prolongamento artificial da vida a qualquer custo.

CE/88 Arts. 1º III, 5º III — STF ADI 3.510 — Dignidade vs. Obstinção Terapêutica

O médico que documenta a recusa do paciente ou de seus representantes a procedimentos específicos, e registra no prontuário, cumpre integralmente seus deveres éticos e legais, mesmo diante de discordâncias futuras.

CFM Res. 2.232/2019 — Arts. 3º, 4º e 6º

A atuação médica pautada por protocolos reconhecidos, com documentação adequada e consentimento devidamente obtido, configura exercício regular de direito, excludente de ilicitude civil e penal. O ônus probatório recai sobre quem alega o dano.

CC/2002 Arts. 186, 187, 927, 951 · CP Art. 23, III · CPC/2015 Art. 373

Os abaixo assinados DECLARAM que: (I) participaram voluntariamente da Conferência Familiar acima descrita; (II) receberam informações claras, completas e compreensíveis sobre o diagnóstico, prognóstico e opções terapêuticas do paciente identificado; (III) tiveram oportunidade de formular perguntas e manifestar discordâncias; (IV) compreendem que as decisões registradas neste documento visam exclusivamente o conforto, a dignidade e o melhor interesse do paciente; e (V) concordam com o Plano Terapêutico Proporcional aqui estabelecido, salvo ressalvas expressamente registradas na Seção 7.

11.1 Médico Responsável

Nome completo:

Médico Responsável

CRM:

Especialidade:

Data:

11.2 Assinaturas dos Familiares / Representantes Legais

Nome: _____ (1)

Grau parentesco:

CPF: _____

Nome: _____ (2)

Grau parentesco:

CPF: _____

Nome: _____ (3)

Grau parentesco:

CPF: _____

Nome: _____ (4)

Grau parentesco:

CPF: _____

Nome: _____ **(5)**

Grau parentesco:

CPF: _____

Nome: _____ (6)

Grau parentesco:

CPF: _____

11.3 Testemunhas (quando aplicável)

Testemunha 1:

Nome: _____

CPF: _____

Testemunha 2:

Nome: _____

CPF: _____

12. HISTÓRICO DE CONFERÊNCIAS E REVISÕES DO PLANO

Nº	DATA	MOTIVO DA REVISÃO / NOVA CONFERÊNCIA	MÉDICO RESPONSÁVEL (CRM)	UBRICAÇÃO
1		Conferência inicial — este documento		
2				
3				
4				

13. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

1. CFM — Resolução nº 1.805/2006: Ortotanásia — Limitação de procedimentos em paciente terminal.
2. CFM — Resolução nº 2.217/2018: Código de Ética Médica vigente — especialmente Arts. 37 e 41.
3. CFM — Resolução nº 2.232/2019: Exercício da recusa terapêutica pelo paciente.
4. CFM — Resolução nº 2.156/2016: Critérios de admissão e alta em UTI.
5. ANCP — Academia Nacional de Cuidados Paliativos: Critérios de qualidade para os cuidados paliativos no Brasil. 2ª ed. 2018.
6. OMS — Organização Mundial da Saúde: Palliative Care — Key Facts. 2020.
7. Constituição Federal do Brasil de 1988: Arts. 1º III, 5º III e X, 196.
8. Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro): Arts. 11, 15, 138–171 e 927.
9. Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde): Art. 2º — Saúde como direito fundamental.
10. Lei Estadual SP nº 10.241/1999: Direitos dos usuários dos serviços de saúde (referencial nacional).
11. STJ — REsp 1.540.580/DF: Responsabilidade civil médica e consentimento informado.
12. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8ª ed. Oxford University Press, 2019.
13. Cherny NI et al. Oxford Textbook of Palliative Medicine. 5ª ed. Oxford University Press, 2015.
14. SBGG/ANCP — Manual de Cuidados Paliativos — Recomendações para abordagem do paciente terminal. 2023.

15. Resolução COFEN nº 564/2017: Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem — Arts. 95–98.

Este documento foi elaborado em conformidade com as diretrizes do CFM, princípios bioéticos internacionais e legislação brasileira vigente. Deve ser arquivado no prontuário físico e/ou eletrônico do paciente, constituindo parte integrante e permanente do histórico clínico. Versão impressa deve conter rubricas em todas as páginas.

Documento gerado em: 18/04/2026 às 23:17 | DOC-PAC-LSV-001 Rev.01/2025 | Para uso hospitalar exclusivo